



-NEUROCLÍNICA E NEUROCIRURGIA -PEDIATRIA

Profa. Juliana Fonteles



- 1. (CETREDE, 2021)** A Doença de Parkinson é uma patologia lenta e crônica do sistema nervoso, em que ocorre uma degenerescência nas células dos gânglios basais, ocasionando uma perda ou interferência na ação da dopamina, que é o principal neurotransmissor dos gânglios basais, e eles contribuem para a precisão e a uniformidade dos movimentos e coordenam as mudanças de posição. Sobre a atuação da fisioterapia nesse contexto, marque a alternativa INCORRETA.
- A. O objetivo geral da fisioterapia não é só tratar os distúrbios já apresentados pelo paciente no momento da sua avaliação. Ele deve também ter conhecimento sobre a possível evolução do quadro e estabelecer metas de prevenção
 - B. A atuação da fisioterapia em conjunto com a equipe poderá variar de acordo com o contexto em que o paciente está inserido, sendo uma intervenção individual ou em grupo.
 - C. Inicialmente o fisioterapeuta, fará uma avaliação para conhecer as demandas apresentadas pelo paciente, sua queixa principal, suas principais dificuldades funcionais, limitações e habilidades presentes. Diante dessa avaliação ele irá elaborar um plano de intervenção com condutas direcionadas individualmente.
 - D. O treino de equilíbrio e a marcha são essenciais pelo alto risco de queda desses pacientes. Nesses exercícios, sugere-se o uso de pistas externas e exercícios mais funcionais com sequências e coordenação.
 - E. A complicação respiratória surge na fase inicial da doença em decorrência de distúrbios relacionados à deglutição, tornando o paciente mais suscetível à pneumonia.



2. (IDECAN, 2017) A doença de *Parkinson* afeta uma região cerebral que contribui para a precisão e a uniformidade dos movimentos e coordenam as mudanças de posição. Nesta doença, as manifestações clínicas podem ser primárias ou essenciais e secundárias. São manifestações secundárias da doença de *Parkinson*, EXCETO:

- A. Face em máscara e distonia.
- B. Instabilidade postural e bradicinesia.
- C. Incoordenação motora e micrografia.
- D. Embaçamento da visão, disartria e sialorreia.



3. **(AOCP, 2016)** É uma neuropatia desmielinizante inflamatória aguda dos nervos espinhais e cranianos, autoimune, que gera um comprometimento motor e sensitivo. Pode ocorrer em qualquer faixa etária e geralmente é súbita, sendo que o comprometimento motor caracteriza-se por fraqueza simétrica, distal e progressiva. A qual neuropatia o enunciado se refere?

- A. Poliomielite.
- B. Síndrome de Guillain-Barré.
- C. Doença de Charcot-Marie-Tooth.
- D. Fibromialgia.
- E. Esclerose Lateral Amiotrófica.



4. (IDECAN, 2013) Um paciente com 15 anos, vítima da Síndrome de *Guillain-Barré* (SGB), ficou internado em terapia intensiva por 21 dias e, ao receber alta, sua família procurou o serviço de fisioterapia de uma clínica-escola para dar continuidade ao seu tratamento. Sobre esta doença e suas respectivas características, analise.

- I. A Síndrome de *Guillain-Barré* (SGB), doença neurológica capaz de provocar fraqueza muscular generalizada que, em alguns casos, pode levar à morte, caracteriza-se como autoimune, com predominância maior em homens na idade de 20 a 30 anos.
- II. Conduz à desmielinização da bainha de mielina e a degeneração axonal dos nervos periféricos.
- III. Acarreta paralisia espástica, arreflexia ascendente e diferença na concentração de proteína no líquido cefalorraquidiano (LCR), caracterizando a dissociação albumino-citológica, que é característica da SGB.
- IV. Os pacientes com SGB apresentam muita dor, descrita como parestesia, disestesia, dor axial e radicular, mialgia, dor articular e desconforto visceral. A fisioterapia motora constitui-se de exercícios passivos, ativo-assistido e ativo dos membros, este último dependendo da melhora da fraqueza muscular.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A. I e IV.
- B. III e IV.
- C. I, II e III.
- D. I, II e IV.
- E. II, III e IV.



5. (INSTITUTO AOCP, 2021) Paciente com 75 anos, sexo masculino, procura clínica de fisioterapia para atendimento e acompanhamento devido a diagnóstico de Parkinson. No momento, encontra-se semidependente na maioria de suas AVD's e deambula com o auxílio de uma bengala. Sobre o tratamento para esse paciente, com base nas informações apresentadas e na fisiopatologia da doença, assinale a alternativa INCORRETA.

- A. A hidroterapia pode beneficiar o ganho de força desse paciente, assim como a melhora / manutenção do equilíbrio.
- B. A eletroterapia e a termoterapia não seriam as principais condutas voltadas para esse caso clínico.
- C. O treino de marcha pode ser realizado, associado ao equilíbrio, já que há uma tendência desse paciente desenvolver marcha parkinsoniana.
- D. A co-contração e condutas que aumentem o tônus muscular são indicadas, já que a patologia tende a desenvolver hipotonia.
- E. Alongamentos e fortalecimentos musculares favorecem o tratamento desse paciente.



6. (AOCP, 2018) Paciente do sexo masculino, 35 anos, internado em unidade de terapia intensiva devido a diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré. No momento, encontra-se no segundo dia de internamento, sedado e em utilização de droga vasoativa, em ventilação mecânica invasiva (TOT), Glasgow 3T. O paciente tem um peso ideal de, aproximadamente, 60 quilos e não possui nenhuma doença de base associada. Em avaliação fisioterapêutica, o profissional encontrou roncos difusos na ausculta pulmonar (MV+, simétrico, com roncos difusos), leve edema em mãos e pés, ADM passiva sem restrições. Gasometria arterial: Ph: 7,28; PaO₂: 60 mmHg; PaCO₂: 55 mmHg; HCO₃: 25 mEq/L. No momento, a FiO₂ fixada no aparelho é de 50%. Sobre o caso clínico citado, assinale a alternativa correta.

- A. A Gasometria arterial do paciente apresenta uma acidose metabólica.
- B. O volume corrente ideal fisiológico para esse paciente deve ser entre 490 e 580 ml, aproximadamente.
- C. O índice de oxigenação desse paciente é de 120.
- D. O HCO₃ na gasometria arterial está acima do valor de normalidade.
- E. A relação PaO₂/FiO₂ do paciente encontra-se dentro dos valores de normalidade.



- 7. (AOCF, 2018)** Paciente de 28 anos, sexo masculino, sofreu acidente automobilístico e foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico (TCE). Chega em UTI intubado, sendo ambuzado pela equipe do setor, Glasgow 3T, sem exames complementares ou de imagem no momento. Em ausculta pulmonar, o fisioterapeuta detecta murmúrio vesicular abolido em pulmão esquerdo (MV+, assimétrico, abolido em HTE, sem RA). Sobre a situação clínica citada, assinale a alternativa que apresenta a primeira conduta a ser tomada pelo fisioterapeuta nesse caso.
- A. O fisioterapeuta deve montar o respirador e ajustar os parâmetros ventilatórios para o paciente, podendo utilizar a modalidade VCV e fixar o tempo inspiratório em 1,8 segundos.
 - B. O fisioterapeuta deve solicitar uma gasometria arterial para ajustes dos parâmetros ventilatórios.
 - C. O fisioterapeuta deve realizar fisioterapia motora com mobilizações passivas para evitar os efeitos deletérios do repouso no leito.
 - D. O fisioterapeuta deve posicionar o paciente em trendelenburg.
 - E. O fisioterapeuta deve discutir com o médico a possibilidade de o paciente estar com uma intubação seletiva, e, se necessário, tracionar o tubo orotraqueal.



8. (AOCP, 2015-EBSERH) A pressão crítica necessária para garantir fornecimento sanguíneo adequado ao cérebro, podendo, em casos de cirurgias cranianas, estar prejudicada a autorregulação, denomina-se

- A. pressão intracraniana (PIC).
- B. pressão de perfusão cerebral (PPC).
- C. pressão arterial média (PAM).
- D. pressão sanguínea arterial (PSA).
- E. pressão venosa cerebral (PVC).



9. (INSTITUTO AOCP, 2015) Em pacientes com AVC isquêmico agudo, recomenda-se evitar $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$ pelo risco de

- A. vasodilatação cerebral.
- B. aumento do fluxo cerebral.
- C. Hiperoxia
- D. isquemia na área de penumbra.
- E. herniação cerebral.



10. (IDECAN, 2014) A Hipertensão Intracraniana (HIC) resulta do aumento da Pressão Intracraniana (PIC) e está associada com o aumento de morbidade e mortalidade na UTI. A estratégia ventilatória em pacientes com HIC inclui a

- A. ausência de PEEP.
- B. manutenção da relação inspiração: expiração invertida.
- C. hiperventilação objetivando uma PaCO_2 igual a 20 mmHg.
- D. manutenção da saturação arterial de O_2 (SaO_2) menor que 92%.
- E. sedação profunda, quando não é possível corrigir a assincronia paciente-ventilador que cursa com elevação da PIC.



11. (UPA- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, 2017) Na avaliação e atendimento de adultos hemiplégicos, após Acidente Vascular Cerebral, é CORRETO afirmar que:

- A. As escalas não são muito utilizadas, uma vez que as capacidades motoras não podem ser quantificadas por escalas e índices.
- B. A Escala de equilíbrio de Berg consiste em tarefas de equilíbrio sobre uma das hemipartes, de transferências e em posturas dinâmicas e estáticas, com o objetivo de discriminar aqueles idosos propensos a quedas.
- C. Bobath, Brunnstrom e Rood são exemplos de escalas que avaliam a função cognitiva de pacientes hemiplégicos.
- D. O tratamento em grupo não é indicado, mesmo nos casos de pacientes mais independentes.



12. (INSTITUTO AOCP, 2015) O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como uma restrição na irrigação cerebral, causando lesão cerebral e déficit neurológico. Quanto à atuação fisioterapêutica no tratamento de pacientes acometidos pelo AVE, assinale a alternativa correta.

- A. O profissional fisioterapeuta nunca deve prescrever a utilização de órteses para estes pacientes.
- B. Um dos objetivos fisioterapêuticos para estes pacientes é minimizar os efeitos da espasticidade.
- C. O fisioterapeuta irá reabilitar apenas o lado acometido dos pacientes, não necessitando de intervenção no lado sadio.
- D. A eletroestimulação para esses pacientes é indicada, independentemente do grau de contração que eles possuem.
- E. O fisioterapeuta deve dar ênfase para o fortalecimento dos músculos flexores de cotovelo e punho do lado afetado, a fim de evitar o padrão motor desenvolvido pelo paciente acometido.



13. (INSTITUTO AOCP, 2014) A espasticidade não significa um distúrbio específico do controle motor, mas descreve um grande número de comportamentos anormais, tal como podem ser encontrados frequentemente em pacientes com lesões neurológicas. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a esses comportamentos anormais.

- A. Reflexo miotático hiperativo.
- B. Sinergias estereotípicas de movimento.
- C. Aumento de resistência em relação ao movimento passivo.
- D. Padrão de postura da extremidade superior estendida e da inferior flexionada.
- E. Uma co-contração excessiva de músculos antagônicos.



14. (BANCA CONSULPLAN- PREFEITURA DE SUZANO, 2019) A disfunção cerebelar é interrupção da integração do retorno sensitivo aferente e do produto motor eferente. A perda da sensação de posição articular pode produzir alguma descoordenação, que pode ficar substancialmente pior quando os olhos são fechados. Os testes, aplicados para avaliação destes distúrbios, buscam avaliar a coordenação do paciente e a sensação de posição articular. Considerando os testes utilizados para este fim, NÃO corresponde a tal avaliação:

- A) Teste de *Wright*.
- B) Teste dedo-nariz.
- C) Teste de *Romberg*.
- D) Teste do calcanhar-jelho.



15. (INSTITUTO AOCP, 2018) A mãe de uma criança do sexo feminino, 6 meses, procura um fisioterapeuta, orientada pelo médico pediatra, para auxílio no desenvolvimento motor, pois a filha não apresenta controle de cervical e o reflexo de moro persiste. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa INCORRETA.

- A. O reflexo de moro é observado até o segundo ou terceiro mês de vida.
- B. O fisioterapeuta pode estimular o controle de cervical com a criança em decúbito dorsal, colocando um objeto em sua frente para que a criança tente alcançá-lo.
- C. Com a idade que essa criança apresenta, deveria estar se rastejando com o abdome para se locomover.
- D. O fisioterapeuta deve estimular o ortostatismo com a criança, a fim de prepará-la para a marcha.
- E. Na avaliação fisioterapêutica, pela idade da criança, o profissional deveria detectar o rolamento para lateral e ventral no desenvolvimento motor dentro dos parâmetros de normalidade.



16. (UPA, 2017) Considerando os reflexos primitivos do primeiro ano de vida, assinale V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, marque a alternativa correspondente:

- I. No reflexo de Moro, ocorre extensão dos braços e das pernas, os quais retornam à flexão em seguida.
 - II. No reflexo de busca, ao estimular a área ao redor da boca, o recém-nascido roda a cabeça na direção do estímulo.
 - III. No reflexo de preensão palmar, o lactente fecha os dedos sem o polegar, quando colocado um objeto na palma da sua mão.
 - IV. Os reflexos posturais permitem que o lactente, de forma automática, mantenha a posição ereta em relação ao seu ambiente.
- A. I - V/ II - V/ III - F/ IV – F.
 - B. I - V/ II - F/ III - F/ IV – V.
 - C. I - F/ II - V / III - V / IV – F.
 - D. I - V/ II - V/ III - V/ IV – V.



17. (CONSULPLAM, 2019) As doenças neuromusculares da infância incluem um grande grupo de patologias, geralmente de caráter hereditário, que afetam a medula espinhal, os nervos periféricos, a placa mioneural e os músculos. As amiotrofias espinhais se caracterizam por um processo degenerativo das células do corno anterior da medula. A incidência é de 1:20.000 nascidos vivos. Em relação aos principais indicadores clínicos, sinais propedêuticos da atrofia muscular espinhal, marque V para os verdadeiros e F para os falsos.

- () Fasciculação em esqueleto axial.
- () História de hipercinesia fetal.
- () Normorreflexia com hipertonia muscular.
- () Tremor fino dos dedos e fraqueza muscular grave.

A sequência está correta em

- A. F, F, F, V.
- B. F, F, V, F.
- C. V, V, V, F.
- D. V, V, V, V.



18. **(AOCP, 2016)** É de extrema importância o conhecimento das paralisias cerebrais pelo profissional fisioterapeuta devido à intensa atuação desse profissional nos pacientes com essas paralisias. Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- A. A tetraparesia espástica acomete os quatro membros em diferentes proporções.
- B. A tetraparesia espástica tem como característica um bom controle cervical.
- C. A diparesia espástica afeta apenas os membros superiores, sendo que os membros inferiores permanecem preservados.
- D. Na criança com hemiparesia espástica, o pescoço permanece virado para o lado acometido.
- E. É comum nos pacientes com tetraparesia atetoide encontrarmos deformidades ósseas, já que eles apresentam hipertonia generalizada.



19. (INSTITUTO AOCP, 2021) Sobre a avaliação fisioterapêutica do paciente neurológico, assinale a alternativa que apresenta a melhor definição de hemiplégico.

- A. Paciente apresenta fraqueza muscular de MMII.
- B. Paciente apresenta perda total de força de MMII.
- C. Paciente apresenta perda total de força de um lado do corpo.
- D. Paciente apresenta fraqueza muscular de um lado do corpo.
- E. Paciente apresenta redução da sensibilidade de um lado do corpo.



20. (IDECAN, 2016) Sobre crianças com Síndrome de *Down*, é correto afirmar que:

- A. O atraso no desenvolvimento neuropsicomotor é explicado pelo grande peso encefálico.
- B. Apresentam dismorfias frequentemente observáveis, entre elas braquicefalia, prega única palmar e instabilidade atlantoaxial.
- C. Entre as alterações no sistema nervoso destaca-se o grande peso encefálico, a pobre mielinização e o número reduzido de neurônios e conexões nervosas.
- D. Terapias que preconizam a estimulação precoce têm papel primordial no desenvolvimento das crianças com Síndrome de *Down*; porém, só devem ter início após estabilização do quadro hemodinâmico, pois alterações cardiológicas graves se fazem presentes em todas as crianças.



21. (INSTITUTO AOCP, 2021) Paciente do sexo feminino, 2 anos, portador de síndrome de Down, está sob atendimento fisioterápico devido a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Sabendo-se dos prejuízos neuromotores causados pela síndrome, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma conduta fisioterapêutica imprescindível para esse paciente.

- A. Fortalecimento de tronco.
- B. Estimulação da marcha.
- C. Treino de coordenação motora fina.
- D. Alongamento prolongado.
- E. Exercícios de dupla função.



GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
E	B	B	D	D	C	E	B	D	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	D	A	B	D	A	A	C	B
21									
D									